

Tratamiento de la tuberculosis resistente a la isoniácida: cerrando brechas sobre seguridad, eficacia y farmacocinética del régimen estándar internacional (Estudio H) versión 1.0

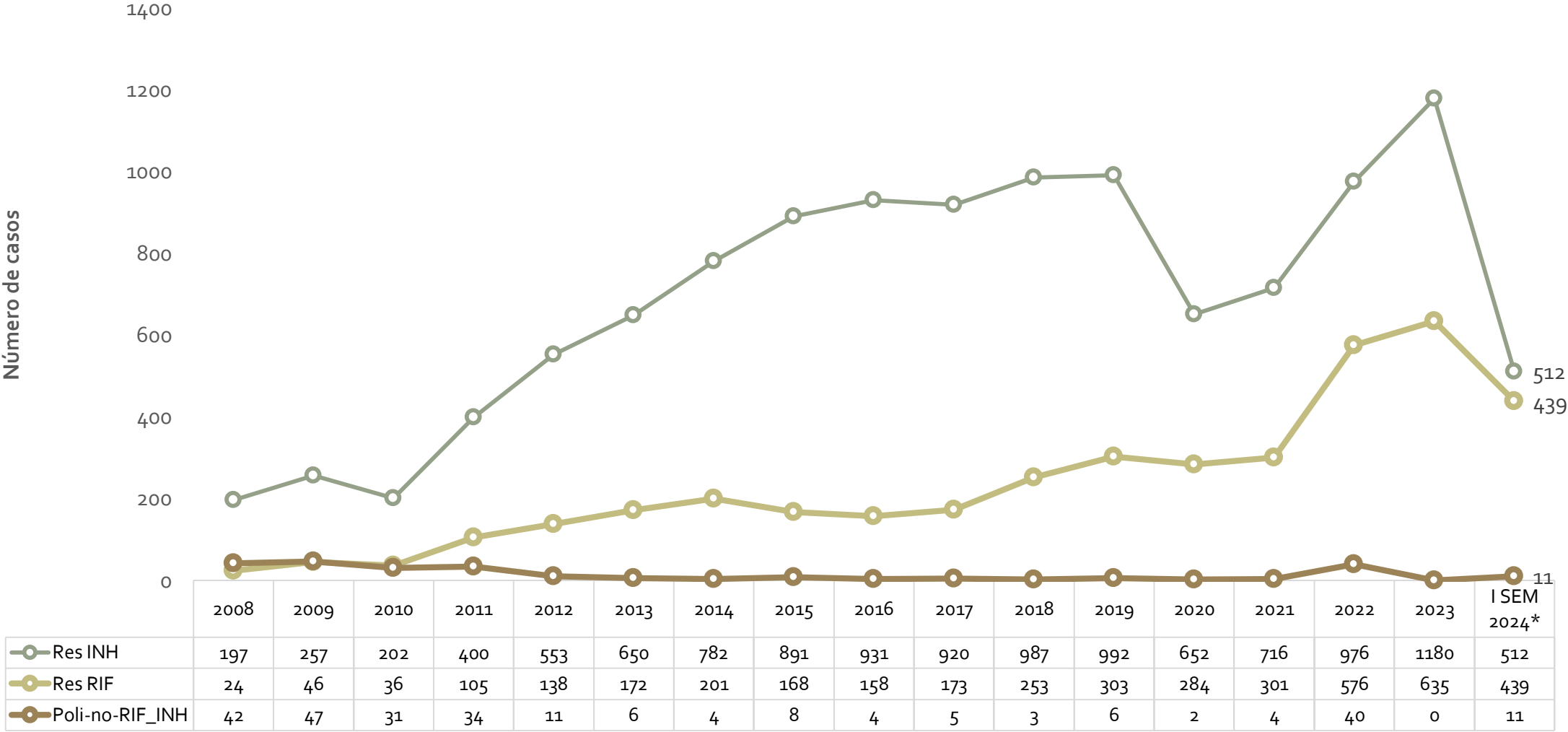
Grupo de Investigación en TB (GIT)

- Socios En Salud
- Instituto Nacional de Salud
 - Universidad de Florida
 - Universidad de Harvard

Racional

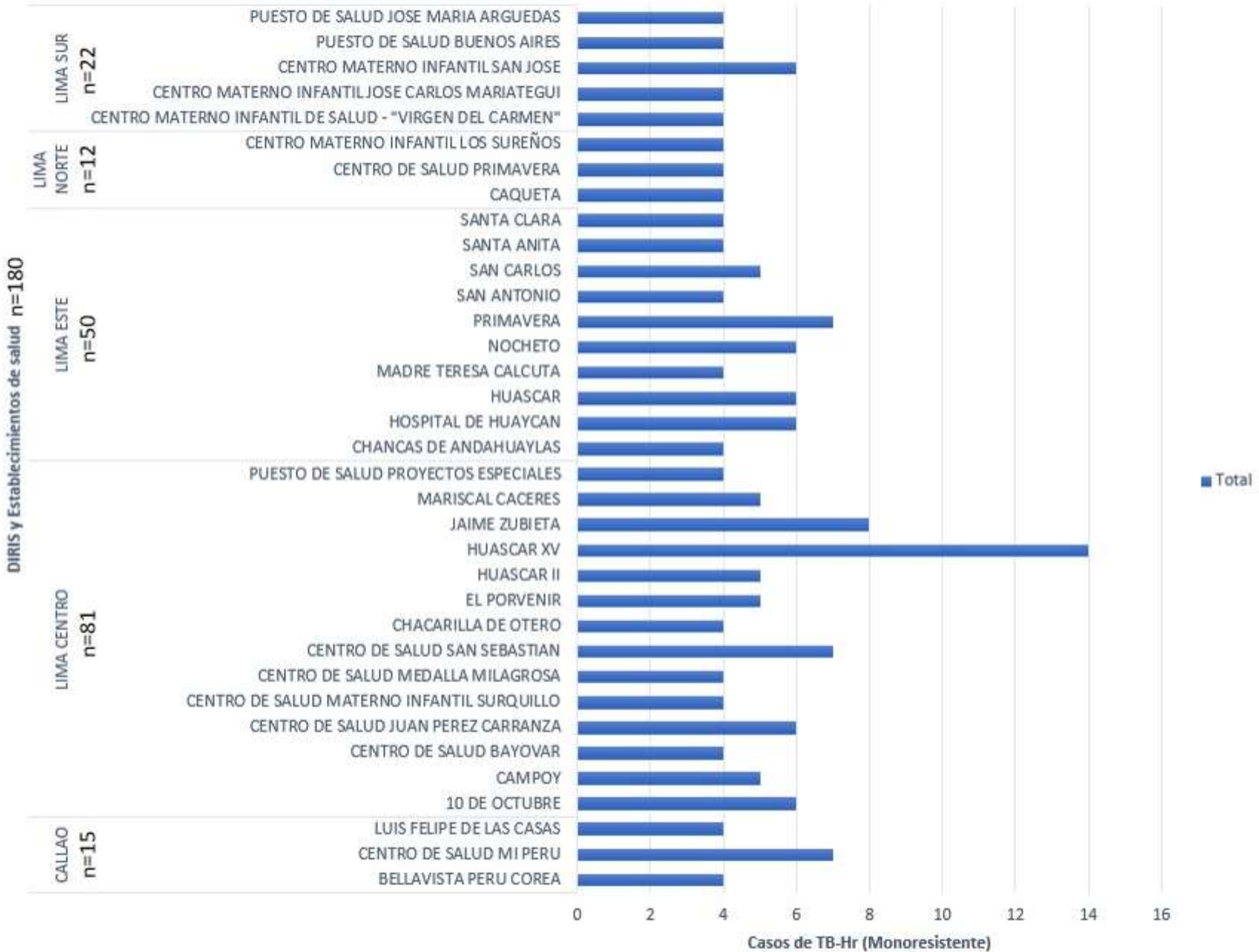
- La resistencia a la isoniacida (INH) es la forma más común de resistencia en todo el mundo (8,4%).
- La TB Hr tiene un mayor riesgo de fracaso terapéutico con HRZE.
- El régimen 6LfxREZ es indicado en guías internacionales y en Perú.
- Su evidencia se basa en estudios observacionales.
- No se conoce adecuadamente la toxicidad y tolerancia de 6LfxREZ.
- No hay sólidos reportes de su eficacia y de interacciones PK entre rifampicina y levofloxacin a dosis convencionales.
- Perú, Lima y Callao, tiene una alta carga de TB Hr (oportunidad para generar evidencia).

CASOS MONORESISTENCIA A INH,RIF,POLI NO RIF-IHN. PERÚ. 2008 – I SEM 2024*

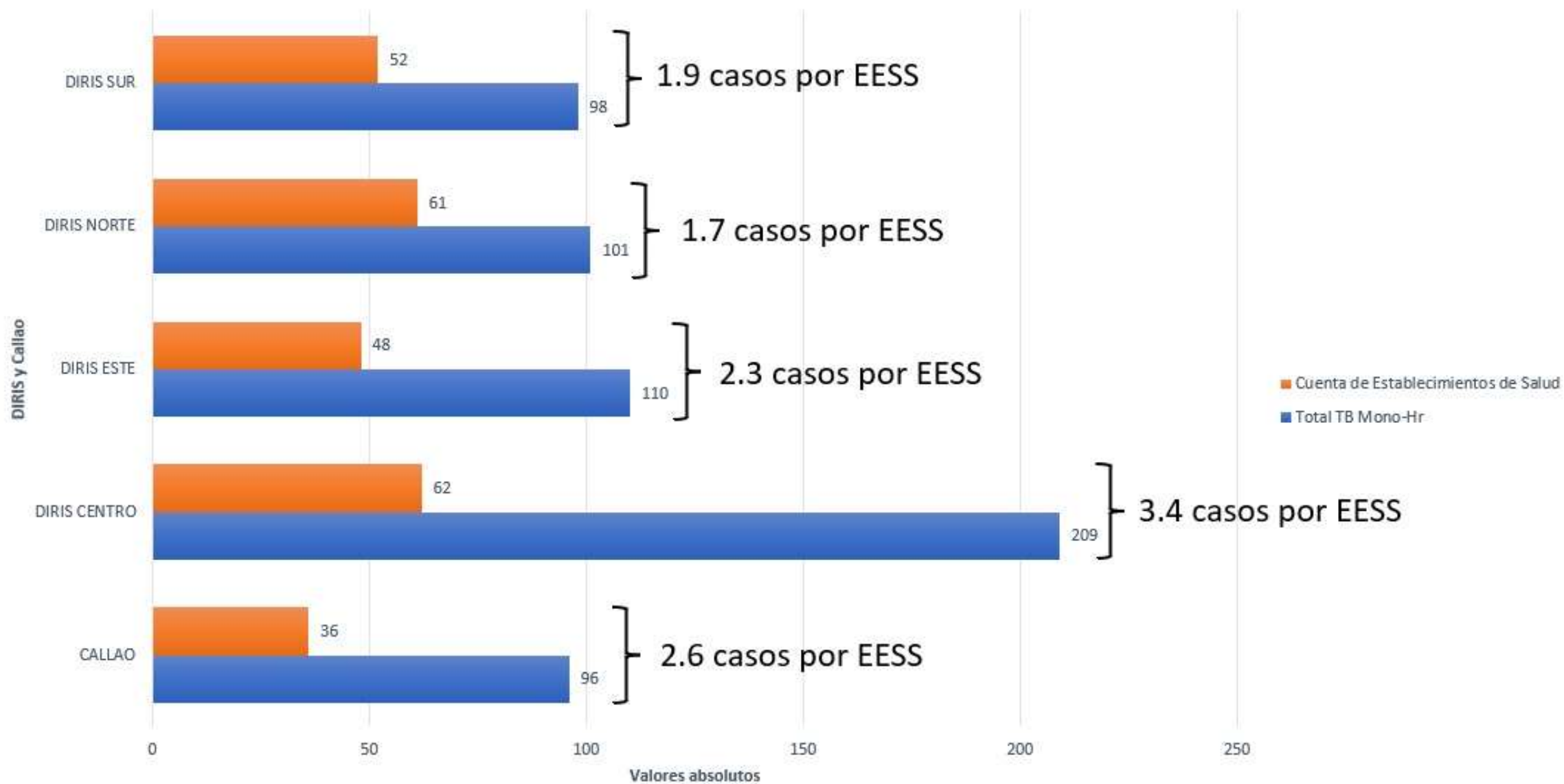


Fuente: SIGTB – RME/DPCTB/DGIESP/MINSA/PERU
Fecha de cierre: 07 de agosto de 2024
* Información preliminar

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TB-Hr EN EESS CON CUATRO O MÁS CASOS EN 2023, LIMA Y CALLAO



Distribución de casos de TB Mono-Hr y E.E.S.S. según Dirección Regional de Salud



MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE EESS CONTRES O MÁS CASOS DE TB Hr EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2023



Objetivos del Protocolo de Investigación (Proyecto H)

General: Determinar la seguridad y eficacia del régimen 6 Lfx-REZ para tratar la TB resistente a la isoniácida y sensible a la rifampicina (TB-Hr) y las interacciones farmacocinéticas entre levofloxacina y rifampicina.

- **Objetivo 1:** Evaluar la seguridad del régimen 6Lfx-REZ mediante farmacovigilancia activa monitorear la aparición evento adverso de grado 3 o superior durante el tratamiento de pacientes con TB-Hr en Lima, Perú.
- **Objetivo 2:** Evaluar la eficacia del régimen 6Lfx-REZ a los 12 meses del inicio del tratamiento con respecto a la meta de éxito de la OMS (90%).
- **Objetivo 3:** Comparar los valores PK/PD entre participantes con y sin conversión del cultivo de esputo a las 8 semanas de tratamiento.

Hipótesis

- **Principal:** El régimen 6Lfx-REZ es bien tolerado por los participantes en el estudio y la toxicidad por Z es frecuente, pero no condiciona una tasa de éxito menor del 90% del régimen.
- **Secundaria:** La interacción farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) entre levofloxacin y rifampicina es mínima y no se asocia a la conversión del cultivo a la semana 8.

Diseño y sujeto de estudio

- Estudio de tipo observacional analítico, con diseño de cohorte prospectiva de personas con diagnóstico de TB-Hr que inician el régimen 6Lfx-REZ.
- La población de estudio estará conformada por personas con diagnóstico de TB-Hr identificadas en el primer nivel de atención de Lima y Callao y que hayan iniciado el régimen 6Lfx-REZ.
- Tamaño de muestra: Se ha estimado enrolar a 218 personas con TB-Hr.

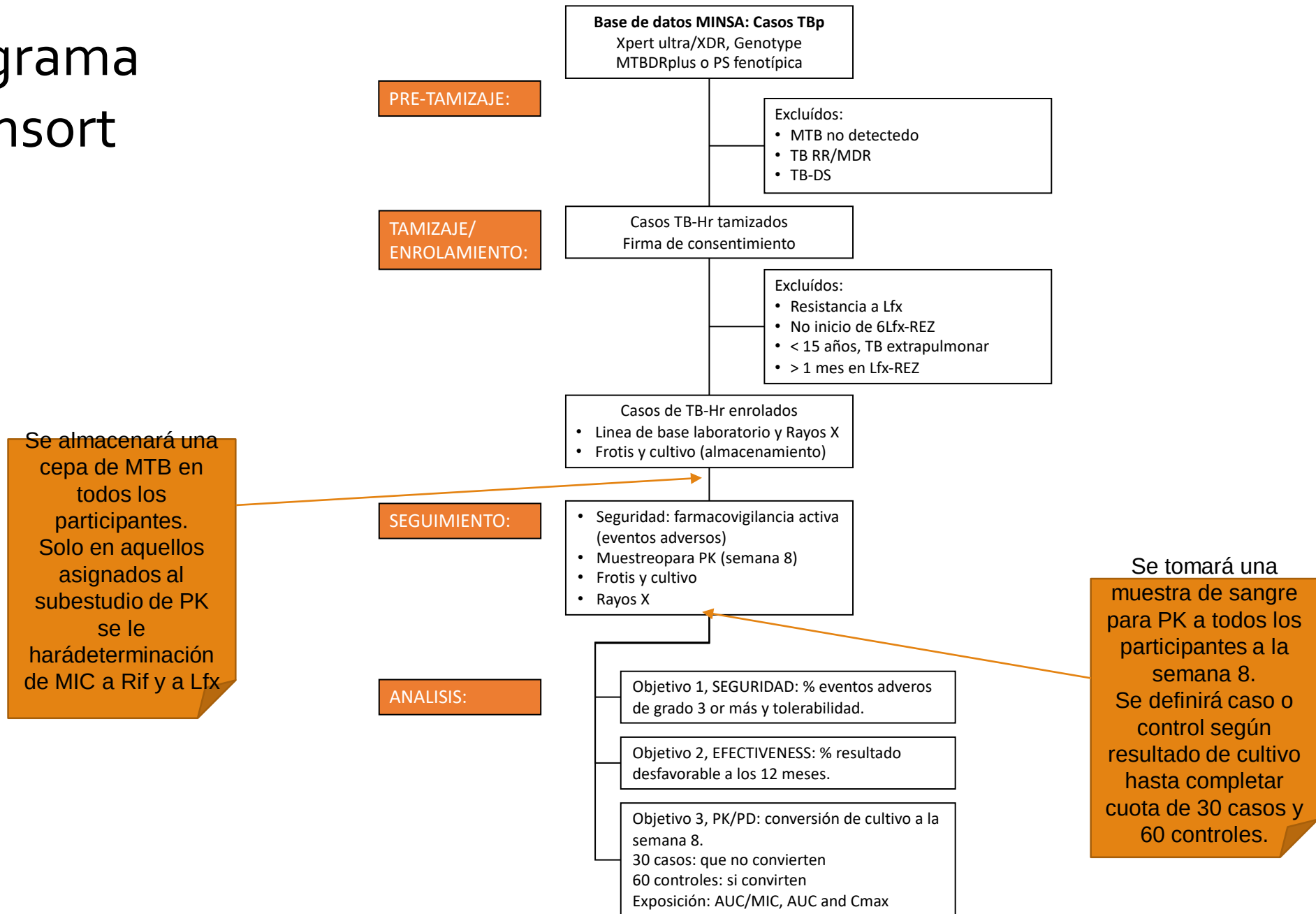
Criterios de inclusión:

- TB pulmonar o mixta, sin compromiso del SNC u OA.
- 15 a más años.
- Diagnóstico de TB Hr (resistente a H y sensible a R).
- Proceder de Lima o Callao.
- Iniciar régimen 6Lfx REZ.
- Resultado de VIH disponible (ingresan con o sin VIH).
- Contar con radiología de tórax basal.
- Capacidad de dar consentimiento o asentimiento y que voluntariamente decidan participar en el estudio.

Criterios de exclusión:

- Resistencia a FQ.
- No disponer de PS a FQ.
- Resistencia a Z o E detectadas por el sistema de salud.
- Más de 30 días recibiendo el régimen 6Lfx-REZ.
- Si la participación en el estudio, compromete la seguridad del paciente.
- No se excluye a gestantes o mujeres que están dando de lactar.

Diagrama Consort



Proeycto H: Cuadro de esquema de eventos

[illegible]

Ética

- Se cuenta con aprobación de CIE de SES
- Se tiene formatos de consentimiento y asentimiento aprobados

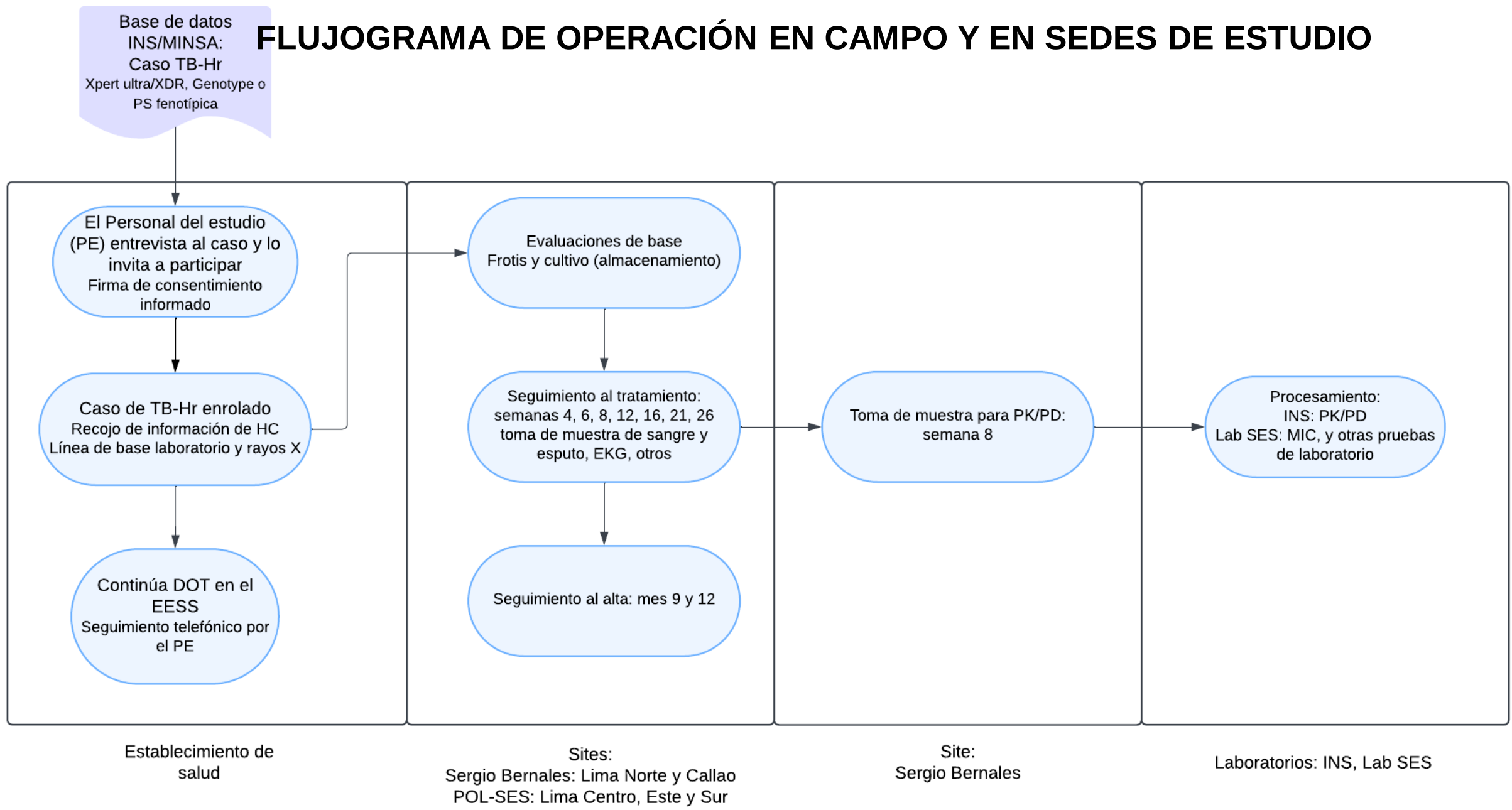


Cronograma

Actividades	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5			
	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4
Preparación/aprobaciones																				
Reclutamiento																				
Seguimiento																				
Análisis																				
Reporte y resultados																				

Fecha de inicio: 18 de junio de 2024
Inicio de reclutamiento: abril 2025
Fecha de término: mayo 2029

FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN EN CAMPO Y EN SEDES DE ESTUDIO



Siguientes pasos

1. Continuar enrolamiento en DIRIS Lima Este.
2. Iniciar enrolamiento en la DIRIS Lima Norte y la DIRESA Callao.
3. Presentación del protocolo a la estrategia de TB de la DIRIS Lima Sur.
4. Iniciar enrolamiento en la DIRIS Lima Sur.
5. Aprobación del Comité de ética de la DIRIS Lima Centro.

P&R

Preguntas y respuestas